เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

1. เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูง มีผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ เป็นวงกว้าง หรือ
2. เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือ
3. เหตุการณ์ที่ผู้บริหารให้ความสนใจเพื่อศึกษาหรือดำเนินการ สอบสวนเชิงลึก หรือ
4. พื้นที่ร้องขอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพินิจของหัวหน้าเวรประจำสัปดาห์ หรือ
5. เหตุการณ์การระบาดที่เข้าตามเกณฑ์ต่อไปนี้

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคติดต่ออันตราย						
กาฬโรค (Plague ; Bubonic, Pneumonic, Septicemic)	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ลงสอบสวนภายใน 12 ชั่วโมง หลังพบเหตุสงสัย (ทุกระดับ, L)	เพื่อตรวจจับและป้องกันการระบาดในประเทศ
ไข้ทรพิษ (Smallpox)	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย		
ไข้เลือดออกไครเมียน คองโก (Crimean - Congo hemorrhagic fever; CCHF)	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย		
ไข้เวสต์ไนล์ (West Nile fever: WNV)	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย		
ไข้เหลือง (Yellow fever)	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย		
ไข้ลาสซา (Lassa fever)	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย		
โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus disease)	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ ยืนยัน ทุกราย		
โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease: MVD)	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย		

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease: EVD)	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ลงสอบสวนภายใน 12 ชั่วโมง หลังพบเหตุสงสัย (ทุกระดับ, L)	เพื่อตรวจจับและป้องกันการระบาดในประเทศ
โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา (Hendra virus disease: HeV),	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ ยืนยัน ทุกราย		
โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ ยืนยัน ทุกราย		
โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome; MERS),	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย,	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ ยืนยัน ทุกราย	ผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ ยืนยัน ทุกราย		
โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hanta virus disease)	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย	ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ทุกราย		
โรคอุบัติใหม่						
โรคอุบัติใหม่ หรือโรคที่นำเข้าจากต่างประเทศ (Emerging infectious disease; EIDs)	ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัยรายแรกของจังหวัด - ผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยันรายแรกของจังหวัด (ไม่นับรวมผู้ป่วยสงสัยที่ได้สอบสวนก่อนหน้านี้) - อัตราป่วยตายสูง	- ผู้ป่วยสงสัยรายแรกของเขตสุขภาพ - ผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยันรายแรกของเขต (ไม่นับรวมผู้ป่วยสงสัยที่ได้สอบสวนก่อนหน้านี้) - พบการระบาดข้ามเขตสุขภาพ	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (ทุกระดับ, B)	เพื่อตรวจจับและป้องกันการระบาดในประเทศ
	หมายเหตุ - อาจมีการปรับเปลี่ยนตามแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนโรคอุบัติใหม่ที่พบ					

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ						
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Influenza Like Illness: ILI)	- ผู้ป่วย ILI เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ภายใน 1 สัปดาห์ ในสถานที่เดียวกันกรณีเรือนจำหรือสถานที่กักกัน ดังนี้ - ผู้ป่วย ILI เป็นกลุ่มก้อน 5 ราย ขึ้นไป ในแดนเดียวกันภายใน 1 สัปดาห์	- ผู้ป่วย ILI เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป ภายใน 1 สัปดาห์ ในสถานที่เดียวกันกรณีเรือนจำหรือสถานที่กักกัน ดังนี้ - ผู้ป่วย ILI เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ในแดนเดียวกันหรือมีการกระจายมากกว่า 1 แดน	- ผู้ป่วย ILI เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 50 รายขึ้นไป ภายใน 1 สัปดาห์ ในสถานที่เดียวกันกรณีเรือนจำหรือสถานที่กักกัน ดังนี้ - มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย หรือมีการกระจาย มากกว่า 1 แดน หรือเหตุการณ์ที่มีอัตราป่วยมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10 2 สัปดาห์ ในสถานที่เดียวกัน - กรณีที่การระบาดไม่สงบภายใน 2 สัปดาห์ ในสถานที่เดียวกัน	- ผู้ป่วย ILI เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 100 รายขึ้นไป ภายใน 2 สัปดาห์ ในสถานที่เดียวกันกรณีเรือนจำหรือสถานที่กักกัน ดังนี้ - เหตุการณ์ที่มีผู้ป่วย ILI มีอัตราป่วยมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 หรือ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (ทุกระดับ, B)	เพื่อควบคุมการระบาดให้ได้ภายใน 2 ระยะฟักตัว และเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
	หมายเหตุ - อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Influenza Like Illness: ILI) หมายถึงผู้ที่มีประวัติมีไข้ ร่วมกับไอ					

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
ปอดอักเสบ (Pneumonia)	- ผู้ป่วยสงสัยปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลันทุกราย - ผู้ป่วยปอดอักเสบที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุขทุกราย ที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทำงาน - ผู้ป่วยปอดอักเสบเสียชีวิตที่ไม่ทราบสาเหตุ ทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยปอดอักเสบเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ใน 2 สัปดาห์ ในสถานที่เดียวกัน	- ผู้ป่วยสงสัยปอดอักเสบเฉียบพลันเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ผู้ป่วยปอดอักเสบที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุขตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทำงาน - ผู้ป่วยสงสัยปอดอักเสบเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปใน 2 สัปดาห์ ในสถานที่เดียวกันที่อำเภอไม่สามารถระบุเชื้อก่อโรคได้กรณีเรือนจำหรือสถานที่กักกัน ดังนี้ - ผู้ป่วยปอดอักเสบตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ภายใน 2 สัปดาห์	- ผู้ป่วยปอดอักเสบสงสัยโรคอุบัติใหม่ทุกราย - ผู้ป่วยปอดอักเสบที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุขตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทำงาน - ผู้ป่วยสงสัยปอดอักเสบเสียชีวิตเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปใน 2 สัปดาห์ ในสถานที่เดียวกัน ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา กรณีเรือนจำหรือสถานที่กักกัน ดังนี้ - ผู้ป่วยสงสัยปอดอักเสบตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่ยังไม่สามารถหาเชื้อก่อโรคได้ ภายใน 2 สัปดาห์ หรือ กระจายมากกว่า 1 แดน หรือ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย	- ผู้ป่วยปอดอักเสบสงสัยโรคอุบัติใหม่ทุกรายกรณีเรือนจำหรือสถานที่กักกัน ดังนี้ - ผู้ป่วยสงสัยปอดอักเสบตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่ยังไม่สามารถหาเชื้อก่อโรคได้ ภายใน 2 สัปดาห์ หรือ กระจายมากกว่า 1 แดน ภายใน 2 สัปดาห์ หรือ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (ทุกระดับ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และลดอัตราป่วย อัตราป่วยตาย (ตรวจการระบาดโรคอุบัติใหม่ในประเทศ)
	หมายเหตุ - ปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลัน คือ ใส่ท่อช่วยหายใจ หรือ เสียชีวิต ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน้อยกว่า 2 วันหรือ 48 ชั่วโมง หรือ กรณีเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ					

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	- ผู้ป่วยเข้าข่ายเสียชีวิตทุกราย - การติดเชื้อในโรงพยาบาล (NI) ที่มีประวัติเริ่มมีอาการหลังเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 7 วัน 2 ราย ขึ้นไป ในหน่วยรักษา/ หอผู้ป่วยเดียวกัน (สงสัยติดเชื้อในโรงพยาบาล)	- การติดเชื้อในโรงพยาบาล (NI) ที่มีประวัติเริ่มมีอาการหลังเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 7 วัน 5 ราย ขึ้นไป ในหน่วยรักษา/ หอผู้ป่วยเดียวกัน (สงสัยติดเชื้อในโรงพยาบาล) - ผู้ป่วยที่พบ Variant of Concern หรือ new Variant ครั้งแรกในจังหวัด	- การติดเชื้อในโรงพยาบาล (NI) ที่มีประวัติเริ่มมีอาการหลังเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 7 วัน โดยพบผู้ป่วยข้ามหน่วยรักษา/ หอผู้ป่วยที่มีประวัติเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา - ผู้ป่วยที่พบ Variant of Concern หรือ new Variant ครั้งแรกในเขตสุขภาพ - ผู้ป่วยตั้งแต่ระดับเข้าข่ายในหลายจังหวัดที่สงสัยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาในเขตเดียวกัน	- การติดเชื้อในโรงพยาบาล (NI) ที่มีประวัติเริ่มมีอาการหลังเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 7 วัน ที่กระจายมากกว่า 50% ของหน่วยรักษา/ หอผู้ป่วย ในสถานพยาบาลนั้นๆ - ผู้ป่วยที่พบ Variant of Concern หรือ new Variant ครั้งแรกในประเทศ - ผู้ป่วยตั้งแต่ระดับเข้าข่ายในหลายเขตที่สงสัยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (ทุกระดับ, B)	เพื่อป้องกันการระบาดในโรงพยาบาล เพื่อตรวจจับสายพันธุ์ใหม่ และเพื่อควบคุมการระบาด
	หมายเหตุ - กรณีพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน หรือเสียชีวิตควรเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโดยวิธี PCR เพื่อเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ต่อไป - กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนให้ยึดตามเกณฑ์ ILI หรือ Pneumonia					

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
ไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza)	- ผู้ป่วยเข้าข่ายเสียชีวิตทุกราย - การติดเชื้อในโรงพยาบาล (NI) ที่มีประวัติเริ่มมีอาการหลังเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 7 วัน 2 ราย ขึ้นไป ในหน่วยรักษา/หอผู้ป่วยเดียวกัน	- ผู้ป่วยเข้าข่าย Influenza A ที่มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิต และไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสายพันธุ์ H1/H3 ทุกราย - การติดเชื้อในโรงพยาบาล (NI) ที่มีประวัติเริ่มมีอาการหลังเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 7 วัน 5 ราย ขึ้นไปในหน่วยรักษา/หอผู้ป่วยเดียวกัน	- การติดเชื้อในโรงพยาบาล (NI) ที่มีประวัติเริ่มมีอาการหลังเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 7 วัน โดยพบผู้ป่วยข้ามหน่วยรักษา/ หอผู้ป่วยที่มีประวัติเชื่อมโยงกัน - ผู้ป่วยตั้งแต่ระดับเข้าข่ายในหลายจังหวัดที่สงสัยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาในเขตเดียวกัน	- การติดเชื้อในโรงพยาบาล (NI) ที่มีประวัติเริ่มมีอาการหลังเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 7 วัน กระจายมากกว่า 50% ของหน่วยรักษา/หอผู้ป่วย ในสถานพยาบาลนั้นๆ - ผู้ป่วยตั้งแต่ระดับเข้าข่ายในหลายเขตที่สงสัยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (ทุกระดับ, B)	เพื่อป้องกันการระบาดในโรงพยาบาล เพื่อตรวจจับไข้หวัดนกและเพื่อควบคุมการระบาด
	หมายเหตุ - กรณีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิตควรเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโดยวิธี PCR เพื่อเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ หรือไข้หวัดนกต่อไป - กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนให้ยึดตามเกณฑ์ ILI หรือ Pneumonia					
ไข้หวัดนก (Avian Influenza)	- กรณีมีเหตุการณ์สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ (ตามเกณฑ์กรมปศุสัตว์) ควรค้นหาผู้ป่วยสงสัยในพื้นที่ - ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	ผู้ป่วยเข้าข่ายทุกราย	ผู้ป่วยยืนยันทุกราย	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (ทุกระดับ, B)	เพื่อตรวจจับและป้องกันการระบาดในประเทศ

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires' disease)	- ผู้ป่วยยืนยันทุกรายที่ได้รับรายงานจากทั้งในและต่างประเทศ	- ผู้ป่วยยืนยันทุกรายที่ได้รับรายงานจากทั้งในและต่างประเทศ	- ผู้ป่วยยืนยัน ที่มีประวัติรับการรักษาในประเทศไทย ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ภายใน 3 เดือน ที่สงสัยติดเชื้อจากสถานที่หรือชุมชนเดียวกัน - ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน ที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานสาธารณสุขต่างประเทศ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปภายในระยะเวลา 3 เดือน ที่สงสัยติดเชื้อจากโรงแรม/สถานที่เดียวกัน - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต ที่มีประวัติการรักษาในประเทศไทย	- ผู้ป่วยยืนยันกลุ่มก้อน (ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป) ที่มีประวัติรับการรักษาในประเทศไทย ภายใน 3 เดือน ที่สงสัยติดเชื้อจากสถานที่หรือชุมชนเดียวกัน - ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน ที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานสาธารณสุขต่างประเทศ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปภายในระยะเวลา 3 เดือน ที่สงสัยติดเชื้อจากโรงแรม/สถานที่เดียวกัน - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต ที่มีประวัติการรักษาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ	ลงสอบสวนภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อควบคุมการระบาดให้ได้ภายใน 2 ระยะฟักตัว

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
วัณโรคปอด (Pulmonary Tuberculosis)	- บุคลากรทางการแพทย์, โรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก - ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกันภายใน 3 เดือน	- บุคลากรทางการแพทย์, โรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก - ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา รายใหม่ (Primary) ดังนี้ 1. วัณโรคดื้อยา Rifampicin (RR-TB) 2. วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) - ผู้ป่วยรายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำ กลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน ภายใน 3 เดือน ผู้ป่วยรายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำ ในเรือนจำ (กรณี มีตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปอยู่ห้องนอนเดียวกัน ภายใน 3 เดือน)	- ผู้ป่วยรายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำ กลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน ภายใน 3 เดือน ผู้ป่วยรายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำ ในเรือนจำ (กรณี มีตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปอยู่ห้องนอนเดียวกันภายใน 3 เดือน) - วัณโรคดื้อยา ทุกราย ดังนี้ 1. วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre-XDR-TB) 2. วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)	-ผู้ป่วยรายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำ กลุ่มก้อนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน ภายใน 3 เดือน ผู้ป่วยรายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำ ในเรือนจำ (กรณี มีตั้งแต่ 10 รายขึ้นไปอยู่ห้องนอนเดียวกันภายใน 3 เดือน) - วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) รายแรกของจังหวัดที่ไม่เคยมีผู้ป่วย - วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ที่มีประวัติเดินทางหรืออาศัยช่วงที่ป่วย ข้ามเขตสุขภาพ	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B) กรณี XDR-TBลงสอบสวนภายใน 12 ชั่วโมง หลังทราบผลการตรวจ (ทุกระดับ, L)	เพื่อควบคุมไม่ให้มีผู้ป่วยเชื้อดื้อยาในgeneration ที่ 2 และเพื่อหาสาเหตุของการดื้อยา
	หมายเหตุ - เคส XDR-TB ที่ได้สอบสวนโรคจนเสร็จกระบวนการแล้วตั้งแต่รับรายงาน เป็น Pre-XDR-TB ให้นับรวมเป็นเหตุการณ์เดียวกัน					

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
ไข้ดำแดง (Scarlet fever)	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป จากสถานที่เดียวกัน ภายใน 1 สัปดาห์	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 สถานที่ขึ้นไป จากจังหวัดเดียวกัน ภายใน 4 สัปดาห์	- การระบาดเป็นกลุ่มก้อน และมีการระบาดข้ามจังหวัด ภายใน 4 สัปดาห์ - การระบาดที่มีภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น Post streptococcal glomerulonephritis (PSGN)	-การระบาดเป็นกลุ่มก้อน และมีการระบาดข้ามเขตสุขภาพ ภายใน 4 สัปดาห์ - การระบาดที่มีภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น Post streptococcal glomerulonephritis (PSGN)	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อควบคุมการระบาดให้ได้ภายใน 2 ระยะฟักตัว และป้องกันอาการไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะไม่ครบตามเกณฑ์

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคทางเดินอาหารและน้ำเป็นสื่อ						
อหิวาตกโรค (Cholera)	- ผู้ป่วยทุกรายที่ตรวจพบเชื้อ V.cholerae	- ผู้ป่วยยืนยันทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไป และมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงในหรือนอกเขตสุขภาพ (เช่น เคสหอยแครง ที่สมุทรปราการ 1 ราย และโคราช 1 ราย แต่มีความเชื่อมโยงกัน เขตต้องสอบสวนโรคทั้งสองเขต)	- ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้งผลตรวจยืนยัน (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย หาสาเหตุของการระบาด และลดอัตราป่วยตาย
	หมายเหตุ - ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ป่วยตรวจพบเชื้อ V.cholerae O1 หรือ O139 (ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก WHO) - กรณีตรวจพบเชื้อ V.cholerae ให้ดำเนินการตรวจ Sero group ต่อไป - กรณีตรวจพบเชื้อ V.cholerae serotype non O1 หรือ non O139 ให้ดำเนินการสอบสวนโรคตามเกณฑ์โรคอุจจาระร่วง					

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โบทูลิซึม (infantile, foodborne, wound, inhalation Botulism)	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัยตั้งแต่ 2 รายที่มีความเชื่อมโยงของการรับประทานอาหารที่สงสัยปนเปื้อนพิษ Clostridium botulinum จากแหล่งเดียวกัน - ผู้ป่วยสงสัยทุกรายที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรคข้ามเขตสุขภาพ - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้ง (ทุกระดับ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และลดอัตราป่วยอัตราป่วยตาย (ควบคุมแหล่งรังโรค)
ไข้เอนเทอริค ไทฟอยด์/พาราไทฟอยด์ (Enteric fever/ Typhoid fever/ Paratyphoid fever)	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนเดียวกัน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนเดียวกัน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ที่ควบคุมการระบาดไม่ได้ภายใน 1 เดือน	- พบผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป - ควบคุมการระบาดไม่ได้ ภายใน 2 เดือน ตั้งแต่ 2 จังหวัดภายในเขตเดียวกัน -ผู้ป่วยยืนยัน 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา -ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิต 2 รายขึ้นไป	- พบผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป - พบผู้ป่วยสงสัยที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ข้ามเขตสุขภาพ - ควบคุมการระบาดไม่ได้ ภายใน 2 เดือน ข้ามเขตสุขภาพ -ผู้ป่วยยืนยัน 5 รายขึ้นไป -ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต 1 รายขึ้นไป	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อควบคุมการระบาดให้ได้ภายใน 2 ระยะฟักตัว และลดอัตราป่วยตายและบริหารจัดการเหตุการณ์ที่พบมีเชื่อมโยงข้ามพื้นที่
	หมายเหตุ - ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ป่วยตรวจพบเชื้อ V.cholerae O1 หรือ O139 (ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก WHO) - กรณีตรวจพบเชื้อ V.cholerae ให้ดำเนินการตรวจ Sero group ต่อไป - กรณีตรวจพบเชื้อ V.cholerae serotype non O1 หรือ non O139 ให้ดำเนินการสอบสวนโรคตามเกณฑ์โรคอุจจาระร่วง					

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
อุจจาระร่วง/ อาหารเป็นพิษ/ บิด (Acute diarrhea/ Food poisoning/ Dysentery)	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนเดียวกัน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป - ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป - ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 50 รายขึ้นไป - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิต ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 20 รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ตั้งแต่ 2 จังหวัดภายในเขตสุขภาพเดียวกัน	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 50 รายขึ้นไป ที่มีผู้ป่วยกระจายมากกว่า 1 จังหวัด - ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 20 รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ข้ามเขตสุขภาพ - ผู้ป่วยเสียชีวิต ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ข้ามเขตสุขภาพ	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อหาสาเหตุการระบาดและควบคุมการระบาดให้ได้ภายใน 2 ระยะฟักตัว
พิษจากสัตว์ พืช และเห็ดจากการรับประทาน	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในชุมชนเดียวกันที่มีประวัติรับประทานสัตว์พิษ/พืชพิษ/เห็ดพิษ - ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกรายที่มีประวัติรับประทานสัตว์พิษ/พืชพิษ/เห็ดพิษ	-ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ที่มีประวัติรับประทานสัตว์พิษ/พืชพิษ/เห็ดพิษจากแหล่งเดียวกัน	- ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 รายขึ้นไป - เหตุการณ์ที่พบผู้ป่วยกระจายมากกว่า 1 จังหวัด และมีประวัติรับประทานสัตว์พิษ/พืชพิษ/เห็ดพิษจากแหล่งเดียวกัน -ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป หรือพบผู้ป่วยตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ขึ้นไปภายใน 2 สัปดาห์ ในจังหวัดเดียวกัน ที่มีประวัติรับประทานสัตว์พิษ/พืชพิษ/เห็ดพิษ	- ผู้ป่วยเสียชีวิต 5 รายขึ้นไป - เหตุการณ์ที่พบผู้ป่วยกระจายมากกว่า 1 เขตสุขภาพ และมีประวัติรับประทานสัตว์พิษ/พืชพิษ/เห็ดพิษจากแหล่งเดียวกัน -ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป หรือพบผู้ป่วย 2 เหตุการณ์ขึ้นไป ภายใน 2 สัปดาห์ ที่มีประวัติรับประทานสัตว์พิษ/พืชพิษ/เห็ดพิษจากแหล่งเดียวกัน	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และบริหารจัดการเหตุการณ์ที่พบมีเชื่อมโยงข้ามพื้นที่

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
ตับอักเสบ A และ E (Acute Viral hepatitis A/E)	- ผู้ป่วยยืนยัน 1 รายขึ้นไป - ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไปในอำเภอเดียวกัน ภายใน 1 เดือน	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปภายใน 1 เดือน - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย - ผู้ป่วยยืนยัน 2 รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ภายใน 1 เดือน - ผู้ป่วยยืนยัน 5 รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิต 2 รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไป (จังหวัดละ 10 รายขึ้นไป) ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต 2 รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อควบคุมการระบาดให้ได้ภายใน 2 ระยะฟักตัว เพื่อหาสาเหตุของการแพร่ระบาด และเพื่อบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงข้ามพื้นที่

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน						
พิษสุนัขบ้า (Human Rabies)	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - เมื่อพบสัตว์ยืนยันติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เพื่อติดตามผู้สัมผัส	- ผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยันทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยที่ไม่สามารถสืบค้นประวัติสัมผัสสัตว์ได้ - เมื่อพบว่าเชื้อในสัตว์อื่นที่ไม่ใช่สุนัขและแมว	- ผู้ป่วยยืนยันทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันที่พบใหม่ในจังหวัดปลอดโรค - ผู้ป่วยยืนยันต่อเนื่องจังหวัดเดียวกันในช่วง 6 เดือน - เหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะมีความเชื่อมโยงในพื้นที่มากกว่า 1 จังหวัด	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อค้นหาผู้สัมผัสที่เสี่ยงติดเชื้อจากสัตว์ที่ยืนยันติดเชื้อ เพื่อลดอัตราการตาย (เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงของเหตุการณ์และแหล่งรังโรค)
	หมายเหตุ: "เขตปลอดโรค" คือ พื้นที่ ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด ที่ได้รับการรับรองให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามคู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า					
บรูเซลโลซิส (Brucellosis)	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันทุกราย	-ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย -ผู้ป่วยยืนยันจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการ -ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต	-ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปที่มีผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย -ผู้เสียชีวิตยืนยันจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการ -ผู้ป่วยยืนยันที่สงสัยติดเชื้อจากคนสู่คน	ลงสอบสวนภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราป่วยตาย (เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงของเหตุการณ์และแหล่งรังโรค)

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในตำบล เดียวกัน ภายใน 1 เดือน - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ในอำเภอเดียวกัน ภายใน 1 เดือน - ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนที่ไม่ใช่ กลุ่มเสี่ยงโดยปกติ เช่น เที่ยวล่องแก่ง หรือหลังน้ำท่วมใหญ่ - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ภายใน 1 เดือน	- ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ภายใน 1 เดือน - ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป และควบคุมการระบาดไม่ได้ภายใน 1 เดือน	- ผู้ป่วยเสียชีวิตตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในเหตุการณ์เดียวกัน - ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา หรือเหตุการณ์ที่ควบคุมการระบาดไม่ได้ภายใน 1 เดือน	ลงสอบสวนภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อลดอัตราการป่วยตาย (เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงของเหตุการณ์และแหล่งรังโรค) และควบคุมการระบาดให้ได้ภายใน 2 ระยะฟักตัว
พยาธิทริคิเนลลา (Trichinosis)	- ผู้ป่วยสงสัย/เข้าข่ายเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป	- ผู้ป่วยสงสัย/เข้าข่ายเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป	- ผู้ป่วยสงสัย/เข้าข่ายเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป	- ผู้ป่วยเข้าข่ายเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป	ลงสอบสวนภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อ containment at the source ค้นหาแหล่งรังโรคและควบคุมการแพร่กระจาย

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคไข้หูดับ (Streptococcus suis infection)	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไป ที่สงสัยว่ามีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ผู้ป่วยเข้าข่ายเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 3 ราย ขึ้นไป ที่สงสัยว่ามีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ที่สงสัยว่ามีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 ราย ขึ้นไป ในจังหวัดเดียวกัน ที่มีผู้เสียชีวิต	- เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดรุนแรงหรือกระจายในวงกว้าง	ลงสอบสวนภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อลดอัตราป่วยตาย (เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงของเหตุการณ์และแหล่งรังโรค) เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว เพื่อบริหารจัดการเหตุการณ์ที่มีความเชื่อมโยงข้ามพื้นที่
แอนแทรกซ์ (Anthrax : Cutaneous/ Intestinal/ Pulmonary)	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	- ผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน ทุกราย	- ผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยันทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยรายแรกของจังหวัด-เหตุการณ์ที่สงสัยก่อการร้าย	- ผู้ป่วยยืนยันทุกราย - ผู้ป่วยสงสัย/เข้าข่ายเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป - เหตุการณ์ที่สงสัยก่อการร้าย	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และป้องกันการระบาดในประเทศ

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน						
โปลิโอ (Poliomyelitis)	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย- ผู้ป่วย VAPP - ผู้ป่วยยืนยันโปลิโอ (Wild type Polio or VDPVs) ทุกราย - พบสายพันธุ์วัคซีนทัยป์ 2 (Sabin 2) ในผู้ป่วย AFP - พบเชื้อโปลิโอในสิ่งแวดล้อม (Wild type Polio or VDPVs)	- ผู้ป่วย VAPP - ผู้ป่วยยืนยันโปลิโอ (Wild type Polio or VDPVs) ทุกราย - พบสายพันธุ์วัคซีนทัยป์ 2 (Sabin 2) ในผู้ป่วย AFP หรือสิ่งแวดล้อม - พบเชื้อโปลิโอในสิ่งแวดล้อม (Wild type Polio or VDPVs)	- ผู้ป่วย VAPP - ผู้ป่วยยืนยันโปลิโอ (Wild type Polio or VDPVs) ทุกราย - พบสายพันธุ์วัคซีนทัยป์ 2 (Sabin 2) ในผู้ป่วย AFP หรือ - พบเชื้อโปลิโอในสิ่งแวดล้อม (Wild type Polio or VDPVs)	- ผู้ป่วยยืนยันโปลิโอ (Wild type Polio or VDPVs) ทุกราย - พบสายพันธุ์วัคซีนทัยป์ 2 (Sabin 2) ในผู้ป่วย AFP หรือสิ่งแวดล้อม - พบเชื้อโปลิโอในสิ่งแวดล้อม (Wild type Polio or VDPVs)	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และป้องกันการระบาดในประเทศ
อาการอัมพาตกล้ามเนื้อ อ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP)	- ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่มีอาการ AFP ทุกราย	- ผู้ป่วย AFP 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาในเวลา 1 เดือน หรือในตำบลเดียวกัน - ผู้ป่วย AFP เสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วย AFP 5 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาในเวลา 1 เดือน หรือในอำเภอเดียวกัน	- ผู้ป่วย AFP 5 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาในเวลา 1 เดือน หรือในอำเภอเดียวกัน	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อตรวจจับการระบาดการระบาดของโปลิโอ

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
หัด (Measles)	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	- กรณีพื้นที่ที่ไม่พบผู้ป่วยยืนยันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ให้ดำเนินการสอบสวนผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 ราย ภายใน 14 วัน ในสถานที่เดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - กรณีพื้นที่ที่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ให้ดำเนินการสอบสวนผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ภายใน 14 วัน ในสถานที่เดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา หรือพบผู้ป่วยกระจายมากกว่า 1 จังหวัด - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย - กรณีควบคุมการระบาดไม่ได้ภายใน 28 วัน	- ผู้ป่วยสงสัยกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 40 รายขึ้นไปในสถานที่เดียวกัน ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา หรือพบผู้ป่วยกระจายมากกว่า 1 จังหวัด - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตตั้งแต่ 2 รายในจังหวัดเดียวกัน - เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดรุนแรงหรือกระจายในวงกว้าง	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว เพื่อบริหารจัดการให้วัคซีนในพื้นที่

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
หัดเยอรมัน (Rubella)	- ผู้ป่วยสงสัย Rubella ทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 ราย ภายใน 14 วัน ในสถานที่เดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ผู้ป่วยยืนยันทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา หรือพบผู้ป่วยกระจายมากกว่า 1 จังหวัด - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย - กรณีควบคุมการระบาดไม่ได้ภายใน 28 วัน	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา หรือพบผู้ป่วยกระจายมากกว่า 1 จังหวัด - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตตั้งแต่ 2 ราย - เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดรุนแรงหรือกระจายในวงกว้าง	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว เพื่อบริหารจัดการให้วัคซีนในพื้นที่
หัดเยอรมันแต่กำเนิด (Congenital Rubella Syndrome)	- ผู้ป่วยสงสัย Congenital Rubella Syndrome ทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยัน Congenital Rubella Syndrome ทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยัน Congenital Rubella Syndrome ตั้งแต่ 2 ราย ในจังหวัดเดียวกันใน 1 ปี	- ผู้ป่วยยืนยัน Congenital Rubella Syndrome ตั้งแต่ 2 ราย ในจังหวัดเดียวกัน ใน 1 ปี	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว เพื่อบริหารจัดการให้วัคซีนในพื้นที่

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
คอตีบ (Diphtheria: Anterior nasal/ Pharygotonsilla/ Laryngeal)	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัยที่ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทั่วไปเข้าได้กับลักษณะเฉพาะของเชื้อคอตีบ (gram positive ที่มีรูปแท่งคล้ายตัวอักษรจีน) - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยที่พบเชื้อหรือสารพันธุกรรมของเชื้อ Corynebacterium diphtheriae โดยไม่รอผล Toxin ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปในจังหวัดเดียวกัน - ผู้ป่วยเข้าข่ายเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยที่พบเชื้อหรือสารพันธุกรรมของเชื้อ Corynebacterium diphtheriae โดยไม่รอผล Toxin ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปในจังหวัดเดียวกัน - ผู้ป่วยเข้าข่ายเสียชีวิต เป็นกลุ่มก้อน 2 รายขึ้นไป ภายใน 14 วัน	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว เพื่อบริหารจัดการให้วัคซีนในพื้นที่
ไอกรน (Pertussis)	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ภายใน 1 เดือน - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป และมีผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย ในสถานที่เดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ภายใน 1 เดือน - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป และมียืนยันอย่างน้อย 1 ราย ในสถานที่เดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ภายใน 1 เดือน	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว เพื่อบริหารจัดการให้วัคซีนในพื้นที่

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
ไข้สมองอักเสบชนิดญี่ปุ่น (Japanese Encephalitis)	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันรายแรกของจังหวัด (ภายในระยะเวลา 5 ปี) - ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน 2 ราย ขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 เดือน	- ผู้ป่วยยืนยันรายแรกของเขตสุขภาพ (ภายในระยะเวลา 5 ปี) - ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน 2 ราย ขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 เดือน	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว เพื่อบริหารจัดการให้วัคซีนในพื้นที่
คางทูม (Mumps)	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ภายใน 1 เดือน - ผู้ป่วยยืนยันที่มีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ ได้แก่ หูชั้นในอักเสบ สมองอักเสบ จากเชื้อไวรัส Mumps ทุกราย (โดยแพทย์วินิจฉัย)	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไปในสถานที่เดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ภายใน 1 เดือน - ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ ภายใน 1 เดือน ใน 2 อำเภอ	- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ ภายใน 1 เดือน จังหวัดเดียวกัน	- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน ภายใน 1 เดือน ใน 2 จังหวัด	ลงสอบสวนภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว เพื่อบริหารจัดการให้วัคซีนในพื้นที่

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
บาดทะยัก (Tetanus)	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัย 2 รายขึ้นไป ใน 1 ปี - ผู้ป่วยยืนยันทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ยืนยันที่มีประวัติการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้น - ผู้ป่วยสงสัย 2 รายขึ้นไป ใน 1 ปี จังหวัดเดียวกัน (สอบสวนประวัติ	- ผู้ยืนยันที่มีประวัติการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้น - ผู้ป่วยสงสัย 3 รายขึ้นไป ใน 1 ปี จังหวัดเดียวกัน	ลงสอบสวนภายใน 1 สัปดาห์ หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย เพื่อลดอัตราป่วยตาย
บาดทะยักในเด็กแรกเกิด (Tetanus neonatorum)	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย- ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันรายแรกของจังหวัดในรอบ 5 ปี	- ผู้ป่วยยืนยันรายแรกของเขตสุขภาพ ในรอบ 5 ปี	ลงสอบสวนภายใน 1 สัปดาห์ หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย เพื่อลดอัตราป่วยตาย
สุกใส (Chickenpox)	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ภายใน 21 วัน - ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่สงสัยเป็นการติดเชื้อในสถานพยาบาล - ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 10 ราย ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ภายใน 21 วัน - ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่สงสัยเป็น การติดเชื้อในสถานพยาบาล - ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยเสียชีวิต ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - มีการระบาดในสถานพยาบาล 2 แห่ง ขึ้นไป	- พบเหตุการณ์การระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ ภายใน 6 สัปดาห์	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนของอาการไม่พบบ่อย (uncommon/rare) ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป - เป็นเหตุการณ์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ร้ายแรง (Serious AEFI) ได้แก่ เสียชีวิต, อาจเป็น อันตรายถึงชีวิต, รับไว้รักษา ในโรงพยาบาล นานตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไป, พิการถาวร หรือไร้ความสามารถ, มีความผิดปกติแต่กำเนิด - อาจจะเกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการให้วัคซีน - อาการหรือภาวะที่สร้างความกังวลหรือ ความตระหนกอย่างมากต่อครอบครัวและชุมชน	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนของอาการไม่พบบ่อย (uncommon/rare) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป - กรณีเสียชีวิตภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค - อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการให้วัคซีน - เป็นอาการหรือภาวะที่ สร้างความกังวลหรือความตระหนกอย่างมากต่อครอบครัวและชุมชน	- มีผู้ป่วย Serious AEFI เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปหลังรับวัคซีนชนิดเดียวกัน/ล๊อตเดียวกัน - อาจจะเกี่ยวข้องกับการ จัดการให้วัคซีน - เป็นอาการหรือภาวะที่ สร้างความกังวลหรือความตระหนกอย่างมากต่อครอบครัวและชุมชน	- มีผู้ป่วย Serious AEFI เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปหลังรับวัคซีนชนิดเดียวกัน/ล๊อตเดียวกัน - เป็นอาการหรือภาวะที่ สร้างความกังวล หรือ ความตระหนกอย่างมากต่อครอบครัวและชุมชน	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย เพื่อตรวจจับการระบาด เพื่อหาสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการฯ เพื่อการบริหารจัดการวัคซีนที่เหมาะสม

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคติดต่อทางระบบประสาท						
ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcemia or Meningococcal meningitis)	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา	- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา หรือพบผู้ป่วยกระจายมากกว่า 1 จังหวัด - เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดรุนแรงหรือกระจายในวงกว้าง	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (ทุกระดับ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและการระบาด เพื่อลดอัตราป่วยตาย เพื่อควบคุมการรระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว
ไข้สมองอักเสบ ไม่ระบุเชื้อสาเหตุ (Encephalitis, unspecified)	- ผู้ป่วยทุกราย ที่สงสัยโรคติดต่อ	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในอำเภอ เดียวกัน ภายใน 1 เดือน - กรณีที่สงสัยเป็นเชื้ออุบัติใหม่	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในอำเภอ เดียวกัน ภายใน 1 เดือน - กรณีที่สงสัยเป็นเชื้ออุบัติใหม่	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนที่หาสาเหตุไม่ได้มากกว่า 10 ราย ในอำเภอ เดียวกัน ภายใน 1 เดือน - กรณีที่ยืนยันเป็นเชื้ออุบัติใหม่	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง (ทุกระดับ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและตรวจจับโรคอุบัติใหม่ เพื่อควบคุมการรระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว
	หมายเหตุ: - ผู้ป่วยไข้สมองอักเสบที่เสียชีวิต โดยไม่สามารถระบุเชื้อสาเหตุได้ ควรเก็บตัวอย่างเนื้อสมอง หรือ CSF ส่งตรวจหาเชื้อสาเหตุ					

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิ (Eosinophilic meningitis)	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ผู้ป่วยเข้าข่ายเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคติดต่อนำโดยแมลง						
ไข้เดงกี่/ ไข้เลือดออกเดงกี่/ ไข้เลือดออกเดงกี่ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง (DF/ DHF/ DSS/ EDS)	- ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกเสียชีวิตทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยทุกราย ที่มีอาการรุนแรง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) สมองอักเสบ (encephalitis) เป็นต้น - ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้เดงกี่/ สงสัยไข้เลือดออก ที่เป็นผู้ป่วย Index case ของชุมชน นับจากวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายสุดท้าย 28 วัน - ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน เช่น โรงเรียน วัด ภายใน 28 วัน - มีการระบาดในชุมชน เกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง หรือพบผู้ป่วยตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปในชุมชนเดียวกัน	- ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกเสียชีวิตทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยทุกรายที่มีอาการรุนแรง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) สมองอักเสบ (encephalitis) เป็นต้น - ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้เดงกี่/ สงสัยไข้เลือดออกเกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ในชุมชน/หมู่บ้านเดียวกัน	- ผู้ป่วยสงสัยทุกรายที่มีอาการรุนแรง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) สมองอักเสบ (encephalitis) เป็นต้น - ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้เดงกี่/สงสัยไข้เลือดออกเกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ในชุมชน/หมู่บ้านเดียวกัน ร่วมกับพบผู้ป่วยเสียชีวิต	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีอาการรุนแรง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) สมองอักเสบ (encephalitis) เป็นต้น - ผู้ป่วยเข้าข่ายไข้เดงกี่/สงสัยไข้เลือดออก เกินค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ ในตำบลเดียวกัน ร่วมกับพบผู้ป่วยเสียชีวิตมากกว่า 1 ราย	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อควบคุมการระบาดให้ได้ภายใน 2 ระยะฟักตัว เพื่อลดอัตราป่วยตาย เพื่อตรวจจับสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรง

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
ไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever)	- ผู้ป่วยสงสัยรายแรกของชุมชน/หมู่บ้าน นับจากวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายสุดท้าย 28 วัน - ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ในตำบลที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อน	- ผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยยืนยัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง ในตำบลเดียวกัน - พบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยัน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาข้ามอำเภอ ภายใน 28 วัน	- พบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันหรือที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยยืนยัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง ในตำบลเดียวกัน - พบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยัน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาข้ามจังหวัด ภายใน 28 วัน - ผู้ป่วยยืนยันที่มีการรุนแรง เช่น สมองอักเสบ (encephalitis) กลุ่มอาการทางระบบประสาท (GBS) - ผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันเสียชีวิตทุกราย	- พบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปข้ามเขตสุขภาพ ภายใน 28 วัน - ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ร่วมกับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เช่น สมองอักเสบ (encephalitis) กลุ่มอาการทางระบบประสาท(GBS) - ผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันเสียชีวิตทุกราย	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อควบคุมการระบาดให้ได้ภายใน 2 ระยะฟักตัว เพื่อตรวจจับสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรง

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection)	- ผู้ป่วยสงสัยรายแรกของชุมชน นับจากวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายสุดท้าย 28 วัน - ผู้ป่วยสงสัย ดังต่อไปนี้ 1) Microcephaly/Congenital zika syndrome 2) GBS/ Neuro complication - หญิงตั้งครรภ์สงสัยติดเชื้อไวรัสซิกาทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันทุกราย (เพื่อดำเนินมาตรการการตรวจหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน)	- ผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันหรือที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยยืนยัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง ในตำบลเดียวกัน - ผู้ป่วยยืนยัน ดังต่อไปนี้ 1) Microcephaly/Congenital zika syndrome 2) GBS/ Neuro complication	- ผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันหรือที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยยืนยัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง ในตำบลเดียวกัน - พบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยัน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาข้ามจังหวัด ภายใน 28 วัน - ผู้ป่วยยืนยัน ดังต่อไปนี้ 1) Microcephaly/ Congenital zika syndrome 2) GBS/ Neuro complication	- ผู้ป่วยยืนยัน ดังต่อไปนี้ 1) Microcephaly/ Congenital zika syndrome ตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไป ในอำเภอเดียวกัน 2) GBS/ Neuro complication ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในอำเภอเดียวกัน - ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน และมีการระบาดต่อเนื่องมากกว่า 4 สัปดาห์ ใน 2 จังหวัดขึ้นไปที่มีพื้นที่ติดกัน	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อตรวจจับผู้ป่วย Microcephaly/ Congenital zika syndrome และ GBS/ Neuro complication เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
มาลาเรีย (Malaria)	ผู้ป่วยยืนยัน (confirmed malaria case) ดังนี้ - ผู้ป่วยยืนยันทุกราย (สอบสวนโดยทีม MP/MC) หน่วยมาลาเรียในพื้นที่ - กรณีที่สอบเบื้องแล้วพบเป็นผู้ป่วยยืนยันที่ติดเชื้อในพื้นที่ (indigenous case) ให้ทีม สสอ. พื้นที่ด้วย ในอำเภอปลอดโรค - ผู้ป่วยยืนยันมากกว่าปีที่ผ่านมา 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ ในตำบลเดียวกัน	ผู้ป่วยยืนยัน (confirmed malaria case) ดังนี้ - ผู้ป่วยยืนยันที่ติดเชื้อในพื้นที่ (indigenous case) มากกว่า 1 รายในหมู่บ้านปลอดโรค - ผู้ป่วยยืนยันที่ได้รับการตัดสินชนิดการติดเชื้อเป็น relapse (ผู้ป่วยที่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนและพบเชื้อชนิดเดิม ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่พักอาศัยนอกพื้นที่แพร่เชื้อ) หรือ induced (ติดเชื้อผ่านทางการถ่ายเลือด) ในจังหวัดปลอดโรค - ผู้ป่วยยืนยันมากกว่าปีที่ผ่านมา 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ ในอำเภอเดียวกัน - พบเชื้อชนิดที่ไม่เคยพบในอำเภอมาก่อน ในรอบปีที่ผ่านมา และเป็น indigenous case - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย	ผู้ป่วยยืนยัน (confirmed malaria case) ดังนี้ - ผู้ป่วยยืนยันที่ติดเชื้อในหมู่บ้าน (indigenous case) ในจังหวัดปลอดโรค 4 สัปดาห์ต่อเนื่อง - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย	ผู้ป่วยยืนยัน (confirmed malaria case) ดังนี้ - ผู้ป่วยยืนยันที่ติดเชื้อในพื้นที่ (indigenous case) ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ ในจังหวัดปลอดโรค - พบผู้ป่วยยืนยันมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ในจังหวัดเดียวกัน	ลงสอบสวนภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อระบุแหล่ง/ชนิดการติดเชื้อ สาเหตุการเกิดโรค รวมถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่เชื้อโดยเฉพาะในพื้นที่ปลอดโรค

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคเท้าช้าง (Filariasis)	- ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการในพื้นที่ทุกราย (ตรวจพบไมโครฟิลาเรียหรือแอนติเจนพยาธิ โรคเท้าช้าง) - ผู้ป่วยปรากฏอาการเข้าได้ กับอาการของโรคเท้าช้างและมีประวัติเข้าพื้นที่ แพร่โรคหรือพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่ 1 ปี ที่ผ่านมา	- ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการในพื้นที่ทุกราย (ตรวจพบไมโครฟิลาเรียหรือแอนติเจนพยาธิโรคเท้าช้าง) ตั้งแต่ 2 อำเภอ ในจังหวัดเดียวกันและมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ในระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา	- ผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อในพื้นที่ (ตรวจพบไมโครฟิลาเรียหรือแอนติเจนพยาธิโรคเท้าช้าง) ตั้งแต่ 2 จังหวัด ในเขต เดียวกันและมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาในระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา	- ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยสปีชีย์ที่ไม่เคยมีรายงานในประเทศไทยทุกราย	ลงสอบสวนภายใน 1 สัปดาห์ หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัยเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่ที่ไม่แพร่โรคแล้ว เพื่อเฝ้าระวังสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยมีรายงานในประเทศ
	หมายเหตุ 1. กรณีพบผู้ป่วยสงสัยให้ตรวจด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูชนิดระยะไมโครฟิลาเรีย หรือ Ag test kit หากพบเชื้อ ถ้าเขตได้รับแจ้งให้สอบสวนและเก็บ ตัวอย่างส่งตรวจเพื่อยืนยันการติดเชื้อก่อนรายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง DDS 2. สปีชีย์ที่เคยมีรายงานในประเทศไทย ได้แก่ W. bancrofti, B. malay					
สครับไทฟัส/ มิวรีนไทฟัส (Scrub typhus/ Murine typhus)	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาในอำเภอเดียวกัน	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ตั้งแต่ 2 อำเภอในจังหวัดเดียวกัน - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา ตั้งแต่ 2 จังหวัดในเขตเดียวกัน - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา	ลงสอบสวนภายใน 1 สัปดาห์ หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคลิชมาเนียสิส (Leishmaniasis: CL, VL, MCL)	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันทุกราย	ผู้ป่วยยืนยันทุกราย ในจังหวัดที่ไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา	- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ภายใน 3 เดือน ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา	ลงสอบสวนภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัยเพื่อยืนยันการระบาดในพื้นที่/หาแหล่งที่มาของแมลงก่อโรค
โรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงและเกล็ดเลือดต่ำ (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome : SFTS)	ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	-ผู้ป่วยยืนยันทุกราย -ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา	-ผู้ป่วยยืนยันทุกราย -ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	
	หมายเหตุ - อาจมีการปรับเปลี่ยนตามแนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนโรคอุบัติใหม่ที่พบ					

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคติดต่อจากการสัมผัส						
ตาแดงจากไวรัส (Viral conjunctivitis)	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ใน 1 สัปดาห์ ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น - กรณีพบผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสายตาทุกราย เช่น สูญเสียการมองเห็น	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป ใน 1 สัปดาห์ ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น - กรณีพบผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสายตาทุกราย เช่น สูญเสียการมองเห็น	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 40 รายขึ้นไป ใน 1 สัปดาห์ ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น - กรณีพบผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสายตาทุกราย เช่น สูญเสียการมองเห็น	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 80 รายขึ้นไป ใน 1 สัปดาห์ ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น - กรณีเกิดจากเชื้อไวรัสสปีชีส์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน	ไม่กำหนดเวลา สายพันธุ์ที่เคยพบได้แก่ 1. EV (COXA, EV70) 2. Adeno virus	เพื่อยืนยันการวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดเพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว เพื่อเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
มือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส (HFMD, Enterovirus infection)	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ใน 1 สัปดาห์ จากสถานที่เดียวกัน - ผู้ป่วยสงสัยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวมน้ำ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สมองอักเสบ กล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน ทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป ใน 1 สัปดาห์ จากสถานที่เดียวกัน - ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หรือเสียชีวิต ทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 30 รายขึ้นไป ใน 1 สัปดาห์ จากสถานที่เดียวกัน - ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หรือเสียชีวิต ทุกราย	- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 30 รายขึ้นไป ใน 1 สัปดาห์ จากสถานที่เดียวกัน - ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หรือเสียชีวิต ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในจังหวัดเดียวกัน	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อควบคุมโรคภายใน 2 ระยะฟักตัวเพื่อลดอัตราป่วยตาย
โรคเรื้อน (Leprosy)	- ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ทุกราย หมายเหตุ : กรณีเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อนยืนยันรายใหม่ในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการสอบสวนโรคมาก่อน สามารถร้องขอให้ทีมสอบสวนโรคจากสคร.ร่วมลงสอบสวนโรคกรณีเป็นรายแรกของพื้นที่นั้นๆ	- ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ที่เป็นผู้ป่วยรายแรกของแต่ละเดือนในแต่ละอำเภอ ยกเว้นกรณีพบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่(หมู่บ้าน)เดิมภายในระยะเวลา 1 เดือน ให้ดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติม	- ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่เป็นผู้ป่วยรายแรกของแต่ละเดือนในแต่ละจังหวัด	- ผู้ป่วยยืนยันที่เป็นเด็ก - เป็นผู้สัมผัสโรค ที่มีความพิการระดับ 2	ลงสอบสวนภายใน 1 เดือนหลังรับแจ้งเหตุ หากยังไม่ได้รับรายงาน SMEs ติดตามต่อ	เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่และลดความพิการในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เกิดจากการค้นหาล่าช้า
	หมายเหตุ : ความพิการระดับ 2 ได้แก่ - ตา: ตาหลับไม่สนิท ม่านตาอักเสบ กระจกตาเป็นฝ้าขุ่น สายตามัวมาก (นับนิ้วมือระยะ 6 เมตรไม่ได้ วัดสายตาได้น้อยกว่า 60/60) - มือ: รูปร่างผิดปกติ นิ้วงอ ข้อติดแข็ง กระดูกหดสั้น มีแผล ข้อมือตก - เท้า: รูปร่างผิดปกตินิ้วงอ ข้อติดแข็ง กระดูกหดสั้น มีแผล เดินเท้าตก					

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
เมลิออยโดสิส (Melioidosis)	- ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรงหรือได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD case) เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในหมู่บ้านเดียวกัน ภายใน 1 เดือน - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันในบุคลากรทางการแพทย์ จากการปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์หรือดูแลผู้ป่วย - ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรงหรือได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD case) เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในหมู่บ้านเดียวกัน ภายใน 1 เดือน - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยยืนยันในบุคลากรทางการแพทย์ จากการปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์หรือดูแลผู้ป่วย - ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในหมู่บ้านเดียวกัน ภายใน 1 เดือน	- ผู้ป่วยยืนยันในบุคลากรทางการแพทย์ จากการปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์หรือดูแลผู้ป่วย - ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในหมู่บ้านเดียวกัน ภายใน 1 เดือน	ลงสอบสวนภายใน 1 สัปดาห์ หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อลดอัตราป่วยตาย (ทราบสาเหตุการเสียชีวิต) เพื่อป้องกันการระบาดในบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
ฝีดาษวานร (Monkeypox, Mpox)	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ที่มีผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย -ผู้ป่วยติดเชื้อ Mpox เสียชีวิต หรือผู้ป่วยที่มีแนวโน้มอาการรุนแรง* -สงสัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตั้งแต่สงสัยหรือยืนยันการติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน -ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ Mpox clade I/Ia/Ib หรือการกลายพันธุ์	-ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนที่มีผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย -ผู้ป่วยติดเชื้อ Mpox เสียชีวิต หรือผู้ป่วยที่มีแนวโน้มอาการรุนแรง* -สงสัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล - ตั้งแต่สงสัยหรือยืนยันการติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน -ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ Mpox cladeI/Ia/Ib หรือการกลายพันธุ์	-ผู้ป่วยยืยันเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ตั้งแต่สงสัยหรือยืนยันการติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน - ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Mpox cladeI/Ia/Ib หรือการกลายพันธุ์รายแรกของจังหวัด	- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา - ตั้งแต่สงสัยหรือยืนยันการติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน - ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Mpox cladeI/Ia/Ib หรือการกลายพันธุ์รายแรกของเขต	ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง (ทุกระดับ, B)	เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และเฝ้าระวังสายพันธุ์ Clade 1 ที่มีอัตราป่วยตายถึง 10%เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและควบคุมโรคภายใน 2 ระยะฟักตัว
	หมายเหตุ : *ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มอาการรุนแรง ได้แก่ 1. รอยโรคบนผิวหนังมากกว่า 100 ตุ่มทั่วร่างกาย 2. ผื่นที่มีเลือดออก (hemorrhagic lession), ผื่นที่มีเนื้อตาย (necrotic lesion), ผื่นที่รวมกัน (confluence lesion) 3. ผู้ป่วยเป็นหญิงตั้งครรภ์ 4. ผู้ป่วยเด็กอายุ ≤ 18 ปี 5. ผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษวานรที่อวัยวะภายใน (Internal ogan involvement) เช่น ปอดอักเสบ สมองอักเสบ การทำงานของหัวใจผิดปรกติ เช่น cadiomyopath, ติดเชื้อที่อวัยวะอื่น ๆ					

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์						
โรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV)	- ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ที่มีประวัติการใช้ PrEP - ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการรับเลือดทุกราย - พบการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ทุกราย	- ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ที่มีประวัติการใช้ PrEP - ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการรับเลือดทุกราย - พบการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ทุกราย	- ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ที่มีประวัติการใช้ PrEP	- ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ที่มีประวัติการใช้ PrEP	ลงสอบสวนภายใน 1 เดือน หลังได้รับแจ้ง (ทุกระดับ, B)	เพื่อตรวจจับเชื้อดื้อยาจากการใช้ PrEP
ซิฟิลิส (Syphilis)	ยกเลิก					
ซิฟิลิสแต่กำเนิด (Congenital Syphilis)	- ผู้ป่วยเข้าข่ายทุกราย (เก็บข้อมูลในแบบสอบสวนส่งเข้าระบบ) - ทารกตายคลอดที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสทุกราย	- ทารกตายทคลอดที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสทุกราย	- ทารกตายคลอดที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ภายใน 1 ปี ในสถานพยาบาลเดียวกัน	-	ลงสอบสวนภายใน 1 เดือน หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อลดอัตราป่วยตาย (ตรวจจับการระบาดและยืนยันวินิจฉัย)
หนองใน (Gonorrhea, Gonococcal Urethritis)	กรณีพบเชื้อดื้อต่อกลุ่มยา extended-spectrum cephalosporin (ESC) ทุกราย	กรณีพบเชื้อดื้อต่อกลุ่มยา extended-spectrum cephalosporin (ESC) รายแรกของอำเภอ	กรณีพบเชื้อดื้อต่อกลุ่มยา extended-spectrum cephalosporin (ESC) รายแรกของจังหวัด	กรณีพบเชื้อดื้อต่อกลุ่มยา extended-spectrum cephalosporin (ESC) รายแรกของเขตสุขภาพ	ลงสอบสวนภายใน 1 เดือน หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	
ตับอักเสบ B และ C (Viral Hepatitis B/C)	ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี	ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี	ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี รายแรกของจังหวัด	ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปีรายแรกของเขตสุขภาพ	ลงสอบสวนภายใน 1 เดือน หลังรับแจ้ง (อำเภอ, B)	เพื่อควบคุมการระบาดภายใน 2 ระยะฟักตัว

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
โรคไม่ติดต่อ						
ภาวะวิกฤตหัวใจและหลอดเลือดฮีทสโตรก หรือการเสียชีวิตในงานวิ่ง	- ผู้ป่วยในงานวิ่งทุกงาน กรณีเกิดเหตุการณ์และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Heat stroke หรือ Stroke หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ทุกราย - ผู้ป่วยที่มีประวัติหัวใจหยุดเต้นในงานวิ่งทุกงาน ทุกราย - ผู้เสียชีวิตในงานวิ่งทุกงาน (ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกระทบกระแทกของร่างกาย) ทุกราย	- ผู้ป่วยในงานวิ่งทุกงาน กรณีเกิดเหตุการณ์และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Heat stroke หรือ Stroke หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ทุกราย - ผู้ป่วยที่มีประวัติหัวใจหยุดเต้นในงานวิ่งทุกงาน ทุกราย - ผู้เสียชีวิตในงานวิ่งทุกงาน (ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกระทบกระแทกของร่างกาย) ทุกราย	- ผู้ป่วยเกิดเหตุการณ์และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Heat stroke หรือ Stroke หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ ผู้ป่วยที่มีประวัติหัวใจหยุดเต้น หรือ ผู้เสียชีวิต (ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกระทบกระแทกของร่างกาย) รวมกันตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปในงานวิ่งเดียวกันทุกงาน	- ผู้ป่วยเกิดเหตุการณ์และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Heat stroke หรือ Stroke หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือผู้ป่วยที่เคยมีประวัติหัวใจหยุดเต้น รวมกันตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป และ ผู้เสียชีวิตจำนวน 1 รายขึ้นไป (ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกระทบกระแทกของร่างกาย) ในงานวิ่งเดียวกันทุกงาน - กรณีเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ในดุลยพินิจที่ผู้บริหารมอบหมาย	ลงสอบสวนภายใน 14 วัน หลังจากได้รับรายงานเหตุการณ์	เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและค้นหาปัจจัยร่วมที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เป็นกลุ่มก้อน
	หมายเหตุ แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค กรณีภาวะวิกฤติหัวใจและหลอดเอด ฮีทสโตรก หรือการเสียชีวิตขณะวิ่งในงานวิ่ง (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) https://ddc.moph.go.th/dncd/journal_detail.php?publish=14872					

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
ภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า (E-cigarette or vaping use-associated lung injury; EVALI)	- ผู้ป่วย/เสียชีวิต ตั้งแต่ สงสัย ทุกราย	- ผู้ป่วย/เสียชีวิต ตั้งแต่ สงสัย ทุกราย	1. ผู้ป่วยยืนยันรายแรกของจังหวัดที่ไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยมาก่อน 2. ผู้ป่วย/เสียชีวิต ตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไป ที่มีผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย ที่เกิดในอำเภอเดียวกัน ภายใน 1 เดือน 3. กรณีเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ในดุลยพินิจที่ผู้บริหารมอบหมาย	1. ผู้ป่วยยืนยันรายแรกของจังหวัดที่ไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยมาก่อน 2. ผู้ป่วย/เสียชีวิต ตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไป ที่มีผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย ที่เกิดในอำเภอเดียวกัน ภายใน 1 เดือน 3. กรณีเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ในดุลยพินิจที่ผู้บริหารมอบหมาย	ลงสอบสวนภายใน 24 - 48 ชั่วโมง หลังการได้รับรายงานเหตุการณ์	1. เพื่อให้ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคยืนยันการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 2. เพื่อค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมหรือประเมินสถานการณ์ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า อันนำไปสู่การออกแบบ หรือกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
การบาดเจ็บ						
จมน้ำ	- ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยเสียชีวิตในกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี ตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไป ในเหตุการณ์เดียวกัน	- ผู้ป่วยบาดเจ็บ (OPD/IPD case) หรือเสียชีวิตในทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ 3 ราย ขึ้นไป ในเหตุการณ์เดียวกัน	- เหตุการณ์ที่น่าสนใจ - เหตุการณ์ที่กระทบต่อการท่องเที่ยว	ไม่กำหนดเวลา	เพื่อทราบปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการจมน้ำ
การบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ	- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป - ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจทุกราย	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในสัปดาห์เดียวกัน - กรณีเสียชีวิตทุกราย	- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ในสัปดาห์เดียวกัน และพื้นที่เดียวกัน เช่น หน้าชายหาดเดียวกัน เป็นต้น - ผู้เสียชีวิตหรืออาการรุนแรงที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน เช่น หน้าชายหาดเดียวกัน เป็นต้น	ไม่กำหนดเวลา	เพื่อทราบปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการบาดเจ็บจากแมงกะพรุน

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
อุบัติเหตุทางถนน (Road Traffic Injury : RTI)	- กรณีอุบัติเหตุของรถพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุข/รถกู้ชีพ ขณะปฏิบัติหน้าที่ มีผู้บาดเจ็บ admit หรือผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป (รวมถึงคู่กรณี) - เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป หรือเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บ admit ร่วมกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป - ประเด็นสนใจของสังคมและผู้บริหาร ได้แก่ รถราชการ/รถรับส่งนักเรียน/รถโดยสารสาธารณะ/นักท่องเที่ยว/อุบัติเหตุเด็กและเยาวชนที่เป็นหมู่คณะ/บุคคลสำคัญ/บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขขณะปฏิบัติหน้าที่	- เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป หรือเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บ admit รวมกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 4 รายขึ้นไป - กรณีอุบัติเหตุของรถพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะปฏิบัติหน้าที่ - ประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคมและผู้บริหาร ได้แก่ 1) บุคคลสำคัญ ได้แก่ เชื้อพระวงศ์ คณะรัฐมนตรี ผู้นำต่างประเทศ พระราชอาคันตุกะ เอกอัครราชทูต ผู้บริหารระดับสูงนอกกระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดขึ้นไปและผู้ว่าราชการจังหวัด) ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (ปลัดกระทรวง รองปลัดฯ ผู้ตรวจฯ อธิบดี รองอธิบดี สาธารณสุขนิเทศก์	- เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป หรือเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บ admit รวมกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป - กรณีอุบัติเหตุของรถพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะปฏิบัติหน้าที่ มีผู้บาดเจ็บ admit หรือเสียชีวิตตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป - ประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคมและผู้บริหาร ได้แก่ 1) บุคคลสำคัญ ได้แก่ เชื้อพระวงศ์ คณะรัฐมนตรี ผู้นำต่างประเทศ พระราชอาคันตุกะ เอกอัครราชทูต ผู้บริหารระดับสูงนอกกระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดขึ้นไปและผู้ว่าราชการจังหวัด) ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (ปลัดกระทรวง รองปลัดฯ ผู้ตรวจฯ อธิบดี รองอธิบดี	- กรณีอุบัติเหตุของรถพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป - เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป หรือเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บ admit ร่วมกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 15 ราย ขึ้นไป - ประเด็นสนใจของสังคมและผู้บริหาร ได้แก่ รถราชการ/รถรับส่งนักเรียน ที่นักเรียนเสียชีวิตตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป /รถโดยสารสาธารณะที่มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป	ไม่กำหนดเวลา	เพื่อทราบปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

โรค	อำเภอ/ศบส.	จังหวัด/กทม.	เขต	ส่วนกลาง	กำหนดเวลาลงสอบสวน	วัตถุประสงค์
อุบัติเหตุทางถนน (Road Traffic Injury : RTI) (ต่อ)		ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลระดับจังหวัด) 2) ประเด็นที่พื้นที่ให้ความสำคัญ 3) กรณีรถนักเรียน รถโดยสารสาธารณะ รถตู้ เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ admit รวมเสียชีวิต 4 รายขึ้นไป 4) กรณีรถกู้ชีพ กู้ภัย ในหรือนอกสังกัดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีผู้บาดเจ็บ admit	สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลระดับจังหวัด) 2) ประเด็นที่สื่อมวลชนส่วนกลางให้ความสำคัญ 3) กรณีรถนักเรียน รถโดยสารสาธารณะ รถตู้ เกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต 2 ราย หรือบาดเจ็บ admit รวมเสียชีวิต 5 รายขึ้นไป 4) กรณีรถกู้ชีพ กู้ภัย ในหรือนอกสังกัดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เสียชีวิต 1 รายขึ้นไป หรือบาดเจ็บ admit รวมกับผู้เสียชีวิต 3 รายขึ้นไป - กรณีจังหวัดเชิญทีมร่วมสอบสวน (ผู้มีประสบการณ์จากระบาดฯ และงานป้องกันบาดเจ็บ ร่วมลงสอบสวน)			

เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง กันยายน 2569

ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์สำหรับการออกดำเนินการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม			
ลำดับ	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สถานพยาบาล สำนักอนามัย กทม.**	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สปคม.**	**กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ / กรมควบคุมโรค**
เกณฑ์สอบสวนโรคเหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูง			
1	**อุบัติภัยสารเคมี :** เหตุการณ์สารเคมีระเบิด ไฟไหม้ รั่วไหล ในสถานประกอบกิจการ เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตราย โรงงานพลุ เป็นต้น <u>โดยเข้าได้กับเกณฑ์ดังนี้</u> 1) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ**ในรัศมี ตั้งแต่ 500 เมตร** จากจุดเกิดเหตุ 2) มีผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ 1 ราย**หรือ**ผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมี/บาดเจ็บจากเหตุการณ์ ตั้งแต่ 5 ราย	**อุบัติภัยสารเคมี :** เหตุการณ์สารเคมีระเบิด ไฟไหม้ รั่วไหล ในสถานประกอบกิจการ เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตราย โรงงานพลุ เป็นต้น <u>โดยเข้าได้ 2 ใน 3 ข้อดังนี้</u> 1) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ**ในรัศมี ตั้งแต่ 500 เมตร** จากจุดเกิดเหตุ 2) มีผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ 2 ราย**หรือ**ผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมี/บาดเจ็บจากเหตุการณ์ ตั้งแต่ 10 ราย 3) มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว และมีประชาชนเข้าพักอาศัย	**อุบัติภัยสารเคมี :** เหตุการณ์สารเคมีระเบิด ไฟไหม้ รั่วไหล ในสถานประกอบกิจการ เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตราย โรงงานพลุ เป็นต้น <u>โดยเข้าได้ 2 ใน 3 ข้อดังนี้</u> 1) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ**ในรัศมี ตั้งแต่ 500 เมตร** จากจุดเกิดเหตุ 2) มีผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ 3 ราย**หรือ**ผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมี/บาดเจ็บจากเหตุการณ์ ตั้งแต่ 15 ราย 3) มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว และมีประชาชนเข้าพักอาศัย
2	**อุบัติภัยสารเคมี :** เหตุการณ์สารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการรั่วไหล ไม่เกิน 10 ตัน (ไม่เกิน 9,072 ลิตร) และไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ	**อุบัติภัยสารเคมี :** เหตุการณ์สารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการรั่วไหล ตั้งแต่ 10 - 500 ตัน (ประมาณ 9,072 - 453,600 ลิตร) และมีผู้ได้รับผลกระทบ	**อุบัติภัยสารเคมี :** เหตุการณ์สารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการรั่วไหล มากกว่า 500 ตัน (มากกว่า 453,600 ลิตร) และมีผู้ได้รับผลกระทบ
3	**โรคหรืออาการที่เกิดจากรังสีแตกตัวหรือรังสีชนิดก่อไอออน :** เหตุการณ์วัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย**หรือ**มีการรั่วไหล <u>อาจมีหรือไม่มี</u> ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน/ประชาชน/ สิ่งแวดล้อม	**โรคหรืออาการที่เกิดจากรังสีแตกตัวหรือรังสีชนิดก่อไอออน :** เหตุการณ์วัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย**หรือ**มีการรั่วไหล<u>อาจมีหรือไม่มี</u> ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน/ประชาชน/ สิ่งแวดล้อม	**โรคหรืออาการที่เกิดจากรังสีแตกตัวหรือรังสีชนิดก่อไอออน :** เหตุการณ์วัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย**หรือ**มีการรั่วไหล <u>อาจมีหรือไม่มี</u> ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน/ประชาชน/ สิ่งแวดล้อม

เกณฑ์สำหรับการออกดำเนินการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม			
ลำดับ	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สถานพยาบาล สำนักอนามัย กทม.**	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สปคม.**	**กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ / กรมควบคุมโรค**
เกณฑ์สอบสวนโรคสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่มีความสำคัญสูง (Non DCIR)			
โรคหรืออาการสำคัญที่ ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562			
โรคจากการประกอบอาชีพ : โรคตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว **<u>นิยามการรายงานและสอบสวนโรค</u>** ➢ **ผู้ป่วยรายใหม่** หมายถึง ผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคพิษตะกั่วจากการประกอบอาชีพ ไม่เคยถูกรายงานเป็นผู้ป่วยโรคดังกล่าวมาก่อน หรือเคยถูกรายงาน ระยะเวลามากกว่า 1 ปี **<u>(ให้รายงานเข้ามาในระบบที่กำหนดและลงสอบสวนโรคตามเกณฑ์ที่กำหนด)</u>** ➢ **ผู้ป่วยรายเก่า** หมายถึง ผู้ที่เคยได้รับการรายงานและเป็นผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคพิษตะกั่วจากการประกอบอาชีพมาก่อน ซึ่งอาจอยู่ระหว่างการรักษา การติดตาม หรือการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 ปี <u>(ยังไม่ต้องให้รายงานเข้ามาในระบบที่กำหนดและลงสอบสวนโรค ยกเว้นพื้นที่ร้องขอหรือเพื่อประเมินการรับสัมผัสตะกั่วหรือประสิทธิผลของมาตรการควบคุม)</u>			
4	ผู้ป่วยยืนยันโรคพิษตะกั่วจากการทำงาน **ตั้งแต่ 1 ราย** (ประวัติเสี่ยง+ระดับตะกั่วในเลือด (Venous Blood Lead) ตั้งแต่ 60 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (ACGIH, 2022))	ผู้ป่วยยืนยันโรคพิษตะกั่วจากการทำงาน **ตั้งแต่ 5 ราย** ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน (ประวัติเสี่ยง+ระดับตะกั่วในเลือด (Venous Blood Lead) ตั้งแต่ 60 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (ACGIH, 2022))	ผู้ป่วยยืนยันโรคพิษตะกั่วจากการทำงาน **ตั้งแต่ 10 ราย** ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน (ประวัติเสี่ยง+ระดับตะกั่วในเลือด (Venous Blood Lead) ตั้งแต่ 60 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (ACGIH, 2022))
5	ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษตะกั่วจากการทำงาน **ตั้งแต่ 1 ราย** (ประวัติเสี่ยง+ระดับตะกั่วในเลือด (Venous Blood Lead) มากกว่า 20 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (ACGIH, 2022))	ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษตะกั่วจากการทำงาน **ตั้งแต่ 5 ราย** ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน (ประวัติเสี่ยง+ระดับตะกั่วในเลือด (Venous Blood Lead) มากกว่า 20 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (ACGIH, 2022))	ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษตะกั่วจากการทำงาน **ตั้งแต่ 10 ราย** ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน (ประวัติเสี่ยง+ระดับตะกั่วในเลือด (Venous Blood Lead) มากกว่า 20 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (ACGIH, 2022))
6	<u>กรณีหญิงตั้งครรภ์</u> ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษตะกั่วจากการทำงาน **ตั้งแต่ 1 ราย** (ประวัติเสี่ยง+ระดับตะกั่วในเลือด (Venous Blood Lead) ตั้งแต่ 5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (ACGIH, 2022))	<u>กรณีหญิงตั้งครรภ์</u> ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษตะกั่วจากการทำงาน **ตั้งแต่ 1 ราย** (ประวัติเสี่ยง+ระดับตะกั่วในเลือด (Venous Blood Lead) ตั้งแต่ 5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (ACGIH, 2022))	<u>กรณีหญิงตั้งครรภ์</u> ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษตะกั่วจากการทำงาน **ตั้งแต่ 2 ราย** ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน (ประวัติเสี่ยง+ระดับตะกั่วในเลือด (Venous Blood Lead) ตั้งแต่ 5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (ACGIH, 2022))

เกณฑ์สำหรับการออกดำเนินการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม			
ลำดับ	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สถานพยาบาล สำนักอนามัย กทม.**	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สปคม.**	**กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ / กรมควบคุมโรค**
โรคจากการประกอบอาชีพ : โรคจากฝุ่นซิลิกา			
7	ผู้เสียชีวิต**หรือ**ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ร่วมกับมีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นซิลิกา **ตั้งแต่ 1 ราย**	ผู้เสียชีวิต**หรือ**ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ร่วมกับมีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นซิลิกา **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน**	ผู้เสียชีวิต**หรือ**ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ร่วมกับมีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นซิลิกา **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน**
8	ผู้ป่วยสงสัยโรคจากฝุ่นซิลิกา มีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นซิลิกา **ร่วมกับ** มีอาการหรืออาการแสดงสอดคล้องกับโรคจากฝุ่นซิลิกา **ตั้งแต่ 1 ราย**	ผู้ป่วยสงสัยโรคจากฝุ่นซิลิกา มีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นซิลิกา **ร่วมกับ** มีอาการหรืออาการแสดงสอดคล้องกับโรคจากฝุ่นซิลิกา **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน**	ผู้ป่วยสงสัยโรคจากฝุ่นซิลิกา มีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นซิลิกา **ร่วมกับ** มีอาการหรืออาการแสดงสอดคล้องกับโรคจากฝุ่นซิลิกา **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน**
9	ผู้ป่วยยืนยันโรคซิลิโคสิส **ตั้งแต่ 1 ราย** (ประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นซิลิกา+ผลภาพรังสีทรวงอก อ่านโดยแพทย์ B Reader การอ่านผลตามเกณฑ์ ILO โดยมีความผิดปกติตั้งแต่ระดับ Profusion 1/0 ขึ้นไป)	ผู้ป่วยยืนยันโรคซิลิโคสิส **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน** (ประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นซิลิกา+ผลภาพรังสีทรวงอก อ่านโดยแพทย์ B Reader การอ่านผลตามเกณฑ์ ILO โดยมีความผิดปกติตั้งแต่ระดับ Profusion 1/0 ขึ้นไป)	ผู้ป่วยยืนยันโรคซิลิโคสิส **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน** (ประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นซิลิกา+ผลภาพรังสีทรวงอก อ่านโดยแพทย์ B Reader การอ่านผลตามเกณฑ์ ILO โดยมีความผิดปกติตั้งแต่ระดับ Profusion 1/0 ขึ้นไป)
โรคจากการประกอบอาชีพ : โรคจากแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) หรือโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอส (แร่ใยหิน)			
10	ผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงต่อการรับสัมผัสแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) **ร่วมกับ** มีอาการหรืออาการแสดงสอดคล้องกับโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอส **ตั้งแต่ 1 ราย** ดังต่อไปนี้ 1) มะเร็งเยื่อหุ้มปอด 2) มะเร็งปอด 3) มะเร็งอื่นๆ ได้แก่ มะเร็งเยื่อหุ้มช่องท้อง มะเร็งอัณฑะ มะเร็งรังไข่ มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งคอหอย มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่	ผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงต่อการรับสัมผัสแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) **ร่วมกับ**มีอาการหรืออาการแสดงสอดคล้องกับโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอส **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน** ดังต่อไปนี้ 1) มะเร็งเยื่อหุ้มปอด 2) มะเร็งปอด	ผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงต่อการรับสัมผัสแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) **ร่วมกับ** มีอาการหรืออาการแสดงสอดคล้องกับโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอส **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน** ดังต่อไปนี้ 1) มะเร็งเยื่อหุ้มปอด 2) มะเร็งปอด

เกณฑ์สำหรับการออกดำเนินการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม			
ลำดับ	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สถานพยาบาล สำนักอนามัย กทม.**	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สปคม.**	**กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ / กรมควบคุมโรค**
		3) มะเร็งอื่นๆ ได้แก่ มะเร็งเยื่อหุ้มช่องท้อง มะเร็งอัณฑะ มะเร็งรังไข่ มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งคอหอย มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่	3) มะเร็งอื่นๆ ได้แก่ มะเร็งเยื่อหุ้มช่องท้อง มะเร็งอัณฑะ มะเร็งรังไข่ มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งคอหอย มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่
11	ผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงต่อการรับสัมผัสแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) **ร่วมกับ** มีภาวะหรือความผิดปกติที่เกิดจากแอสเบสตอส ได้แก่ เยื่อหุ้มปอดอักเสบจากแอสเบสตอส, ภาวะปื้นเยื่อหุ้มปอด (pleural plaque), ภาวะปื้นเยื่อหุ้มปอดหนากระจาย (diffuse pleural thickening) **ตั้งแต่ 1 ราย**	ผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงต่อการรับสัมผัสแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) **ร่วมกับ** มีภาวะหรือความผิดปกติที่เกิดจากแอสเบสตอส ได้แก่ เยื่อหุ้มปอดอักเสบจากแอสเบสตอส, ภาวะปื้นเยื่อหุ้มปอด (pleural plaque), ภาวะปื้นเยื่อหุ้มปอดหนากระจาย (diffuse pleural thickening) **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน**	ผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงต่อการรับสัมผัสแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) **ร่วมกับ** มีภาวะหรือความผิดปกติที่เกิดจากแอสเบสตอส ได้แก่ เยื่อหุ้มปอดอักเสบจากแอสเบสตอส, ภาวะปื้นเยื่อหุ้มปอด (pleural plaque), ภาวะปื้นเยื่อหุ้มปอดหนากระจาย (diffuse pleural thickening) **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน**
12	ผู้ป่วยยืนยันโรคแอสเบสโตสิส (asbestosis) **ตั้งแต่ 1 ราย** (ประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) + ผลภาพรังสีทรวงอก อ่านโดยแพทย์ B Reader การอ่านผลตามเกณฑ์ ILO โดยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแอสเบสโตสิส)	ผู้ป่วยยืนยันโรคแอสเบสโตสิส (asbestosis) **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน** (ประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) + ผลภาพรังสีทรวงอก อ่านโดยแพทย์ B Reader การอ่านผลตามเกณฑ์ ILO โดยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแอสเบสโตสิส)	ผู้ป่วยยืนยันโรคแอสเบสโตสิส (asbestosis) **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน** (ประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสแอสเบสตอส (แร่ใยหิน) + ผลภาพรังสีทรวงอก อ่านโดยแพทย์ B Reader การอ่านผลตามเกณฑ์ ILO โดยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแอสเบสโตสิส)
โรคจากการประกอบอาชีพ : โรคจากภาวะอับอากาศ			
13	ผู้เสียชีวิต ในที่อับอากาศ **ตั้งแต่ 1 ราย**	ผู้เสียชีวิต ในที่อับอากาศ **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน**	ผู้เสียชีวิต ในที่อับอากาศ **ตั้งแต่ 3 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน**
14	ผู้ป่วยมีประวัติการทำงานในที่อับอากาศ **ร่วมกับ** มีอาการขณะอยู่ในพื้นที่อับอากาศ เช่น ปวดศีรษะ มึนงง วิงเวียน หน้ามืด หายใจไม่ออก คลื่นไส้ อาเจียน และชัก เป็นต้น **ตั้งแต่ 1 ราย**	ผู้ป่วยมีประวัติการทำงานในที่อับอากาศ **ร่วมกับ** มีอาการขณะอยู่ในพื้นที่อับอากาศ เช่น ปวดศีรษะ มึนงง วิงเวียน หน้ามืด หายใจไม่ออก คลื่นไส้ อาเจียน และชัก เป็นต้น **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน**	ผู้ป่วยมีประวัติการทำงานในที่อับอากาศ **ร่วมกับ** มีอาการขณะอยู่ในพื้นที่อับอากาศ เช่น ปวดศีรษะ มึนงง วิงเวียน หน้ามืด หายใจไม่ออก คลื่นไส้ อาเจียน และชัก เป็นต้น **ตั้งแต่ 3 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน**

เกณฑ์สำหรับการออกดำเนินการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม			
ลำดับ	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สถานพยาบาล สำนักอนามัย กทม.**	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สปคม.**	**กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ / กรมควบคุมโรค**
โรคจากการประกอบอาชีพ : โรคหรืออาการสำคัญของพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช			
15	ผู้เสียชีวิต จากการทำงานสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช (ไม่รวมกรณีที่เจตนาฆ่าตัวตายหรือถูกทำร้าย) **ตั้งแต่ 1 ราย**	ผู้เสียชีวิต จากการทำงานสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช (ไม่รวมกรณีที่เจตนาฆ่าตัวตายหรือถูกทำร้าย) **ตั้งแต่ 1 ราย**	ผู้เสียชีวิต จากการทำงานสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช (ไม่รวมกรณีที่เจตนาฆ่าตัวตายหรือถูกทำร้าย **ตั้งแต่ 1 ราย**
16	ผู้ป่วยที่มีประวัติการทำงานสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช **ร่วมกับ**มีอาการ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นคัน แสบจมูก เป็นต้น ภายใน 24 ชั่วโมงหลังสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (OPD/IPD) **ตั้งแต่ 3 ราย ในสถานที่ทำงานหรือในหมู่บ้านเดียวกันในระยะเวลา 1 สัปดาห์**	ผู้ป่วยที่มีประวัติการทำงานสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช **ร่วมกับ**มีอาการ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นคัน แสบจมูก เป็นต้น ภายใน 24 ชั่วโมงหลังสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (OPD/IPD) **ตั้งแต่ 5 ราย ในสถานที่ทำงานหรือในหมู่บ้านเดียวกันในระยะเวลา 1 สัปดาห์**	ผู้ป่วยที่มีประวัติการทำงานสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช **ร่วมกับ**มีอาการ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นคัน แสบจมูก เป็นต้น ภายใน 24 ชั่วโมงหลังสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (OPD/IPD) **ตั้งแต่ 10 ราย ในสถานที่ทำงานหรือในหมู่บ้านเดียวกันในระยะเวลา 1 สัปดาห์**
โรคจากสิ่งแวดล้อม : โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว			

นิยามกลุ่มประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ

1. ประชาชนกลุ่มเปราะบาง หมายถึง ประชาชนกลุ่มที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงแม้ได้รับสัมผัสมลพิษในปริมาณที่อาจไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มประชาชนทั่วไป ได้แก่ เด็ก (0-5 ปี) หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่ป่วยด้วยโรค ดังนี้ ภาวะโลหิตจาง ภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น
2. ประชาชนกลุ่มรับสัมผัสสูง หมายถึง ประชาชนที่มีโอกาสในการรับสัมผัสสารมลพิษในปริมาณที่สูง ทั้งนี้สามารถประเมินการรับสัมผัสได้ทั้งจากการตรวจวัดในสภาพแวดล้อมหรือในตัวบุคคลผู้รับสัมผัส แล้วทำการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานหรือค่าอ้างอิง ในกรณีประชาชนกลุ่มเปราะบางเมื่อตรวจพบว่ามีการรับสัมผัสสูงจะมีโอกาสมีผลกระทบทางสุขภาพรุนแรงมากขึ้น

นิยามการรายงานและสอบสวนโรค

- **ผู้ป่วยรายใหม่** หมายถึง ผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคพิษตะกั่วจากสิ่งแวดล้อม ไม่เคยถูกรายงานเป็นผู้ป่วยโรคดังกล่าวมาก่อน หรือเคยถูกรายงาน ระยะเวลามากกว่า 1 ปี **(ให้รายงานเข้ามาในระบบที่กำหนดและลงสอบสวนโรคตามเกณฑ์ที่กำหนด)**
- **ผู้ป่วยรายเก่า** หมายถึง ผู้ที่เคยได้รับการรายงานและเป็นผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคพิษตะกั่วจากสิ่งแวดล้อมมาก่อน ซึ่งอาจอยู่ระหว่างการรักษา การติดตาม หรือการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 ปี (ยังไม่ต้องให้รายงานเข้ามาในระบบที่กำหนดและลงสอบสวนโรค ยกเว้นพื้นที่ร้องขอหรือเพื่อประเมินการรับสัมผัสตะกั่วหรือประสิทธิผลของมาตรการควบคุม)

เกณฑ์สำหรับการออกดำเนินการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม			
ลำดับ	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สถานพยาบาล สำนักอนามัย กทม.**	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สปคม.**	**กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ / กรมควบคุมโรค**
17	**<u>กรณีผู้ป่วยยืนยันโรคฯเสียชีวิต</u>** ประชาชนกลุ่มเปราะบาง **หรือ**ประชาชนกลุ่มรับสัมผัสสูง เสียชีวิตจากโรคพิษตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว **ตั้งแต่ 1 ราย**	**<u>กรณีผู้ป่วยยืนยันโรคฯเสียชีวิต</u>** ประชาชนกลุ่มเปราะบาง **หรือ**ประชาชนกลุ่มรับสัมผัสสูง เสียชีวิตจากโรคพิษตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือหมู่บ้านเดียวกันในระยะเวลา 1 ปี**	**<u>กรณีผู้ป่วยยืนยันโรคฯเสียชีวิต</u>** ประชาชนกลุ่มเปราะบาง **หรือ**ประชาชนกลุ่มรับสัมผัสสูง เสียชีวิตจากโรคพิษตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว **ตั้งแต่ 3 ราย ในเหตุการณ์หรือหมู่บ้านเดียวกันในระยะเวลา 1 ปี**
18	**<u>กรณีผู้ป่วยยืนยันโรคฯ</u>** ประชาชนกลุ่มเปราะบาง **หรือ**ประชาชนกลุ่มรับสัมผัสสูง ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ด้วยโรคพิษตะกั่ว **ตั้งแต่ 1 ราย**	**<u>กรณีผู้ป่วยยืนยันโรคฯ</u>** ประชาชนกลุ่มเปราะบาง **หรือ**ประชาชนกลุ่มรับสัมผัสสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ด้วยโรคพิษตะกั่ว **ตั้งแต่ 5 ราย ในเหตุการณ์หรือหมู่บ้านเดียวกันในระยะเวลา 1 ปี**	**<u>กรณีผู้ป่วยยืนยันโรคฯ</u>** ประชาชนกลุ่มเปราะบาง **หรือ**ประชาชนกลุ่มรับสัมผัสสูง ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ด้วยโรคพิษตะกั่ว **ตั้งแต่ 10 ราย ในเหตุการณ์หรือหมู่บ้านเดียวกันในระยะเวลา 1 ปี**
19	**<u>กรณีผู้ป่วยสงสัยโรคฯ</u>** ประชาชนกลุ่มเปราะบาง **หรือ**ประชาชนกลุ่มรับสัมผัสสูง ที่มีประวัติการรับสัมผัส (Exposure) ตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว **ร่วมกับ** มีอาการหรืออาการแสดงสอดคล้องกับโรคพิษตะกั่ว **หรือ**มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Venous Blood Lead) พบค่าตะกั่วเกินค่าอ้างอิงมาตรฐานตามศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) ดังนี้ 1) เด็ก มากกว่าหรือเท่ากับ 5 µg/dL **ตั้งแต่ 1 ราย** 2) หญิงตั้งครรภ์ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 µg/dL **ตั้งแต่ 1 ราย** 3) ผู้ใหญ่ มากกว่า 10 µg/dL **ตั้งแต่ 1 ราย**	**<u>กรณีผู้ป่วยสงสัยโรคฯ</u>** ประชาชนกลุ่มเปราะบาง **หรือ**ประชาชนกลุ่มรับสัมผัสสูง ที่มีประวัติการรับสัมผัส (Exposure) ตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว **ร่วมกับ** มีอาการหรืออาการแสดงสอดคล้องกับโรคพิษตะกั่ว **หรือ**มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Venous Blood Lead) พบค่าตะกั่วเกินค่าอ้างอิงมาตรฐานตามศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) ดังนี้ 1) เด็ก มากกว่าหรือเท่ากับ 5 µg/dL **ตั้งแต่ 3 ราย ในเหตุการณ์หรือหมู่บ้านเดียวกัน** 2) หญิงตั้งครรภ์ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 µg/dL **ตั้งแต่ 1 ราย** 3) ผู้ใหญ่ มากกว่า 10 µg/dL **ตั้งแต่ 5 ราย ในเหตุการณ์หรือหมู่บ้านเดียวกันในระยะเวลา 1 ปี**	**<u>กรณีผู้ป่วยสงสัยโรคฯ</u>** ประชาชนกลุ่มเปราะบาง **หรือ**ประชาชนกลุ่มรับสัมผัสสูงที่มีประวัติการรับสัมผัส (Exposure) ตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว **ร่วมกับ** มีอาการหรืออาการแสดงสอดคล้องกับโรคพิษตะกั่ว **หรือ**มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Venous Blood Lead) พบค่าตะกั่วเกินค่าอ้างอิงมาตรฐานตามศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) ดังนี้ 1) เด็ก มากกว่าหรือเท่ากับ 5 µg/dL **ตั้งแต่ 5 ราย ในเหตุการณ์หรือหมู่บ้านเดียวกัน** 2) หญิงตั้งครรภ์ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 µg/dL **ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์หรือหมู่บ้านเดียวกัน** 3) ผู้ใหญ่ มากกว่า 10 µg/dL **ตั้งแต่ 5 ราย ในเหตุการณ์หรือหมู่บ้านเดียวกัน**

เกณฑ์สำหรับการออกดำเนินการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม			
ลำดับ	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สถานพยาบาล สำนักอนามัย กทม.**	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สปคม.**	**กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ / กรมควบคุมโรค**
โรคจากสิ่งแวดล้อม : โรคหรืออาการสำคัญที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน			
ดำเนินการสอบสวนเมื่อเกิดโรคหรือเหตุการณ์ในพื้นที่สีแดง ซึ่งเข้าได้กับนิยาม ดังต่อไปนี้ **1. นิยามกลุ่มประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ** **1) ประชาชนกลุ่มเปราะบาง** หมายถึง ประชาชนกลุ่มที่ได้รับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในปริมาณที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มประชาชนทั่วไป แต่มีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงในกลุ่มนี้ ดังนี้ 1.1 ผู้ที่มีความไวต่อการรับสัมผัส เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีความสามารถของร่างกายในการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนน้อยกว่าคนทั่วไป 1.2 ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาสุขภาพ ทำให้เมื่อได้รับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก็จะมีอาการรุนแรง เช่น ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น **2) ประชาชนกลุ่มรับสัมผัสสูง** หมายถึง ประชาชนที่มีโอกาสในการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเกินค่ามาตรฐานและประชาชนที่มีโอกาสรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมากกว่าคนทั่วไป เช่น ตำรวจจราจร คนขับรถสาธารณะ คนกวาดถนน พ่อค้าแม่ค้าริมถนน เป็นต้น **หมายเหตุ** สำหรับประชาชนที่ทำงานในสถานประกอบกิจการที่สัมผัสกับฝุ่นให้พิจารณาเป็นพิเศษ **2. นิยามระดับของฝุ่นละออง $PM_{2.5}$ ที่ใช้ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ** **พื้นที่สีแดง** หมายถึง พื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่ทำการตรวจวัดโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร หรือเครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองจากกรมควบคุมมลพิษ ได้**ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 75.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ($\mu g/m^3$) ติดต่อกันนาน 3 วัน** * กรณีตำบลหรือแขวงที่ไม่มีสถานีตรวจวัด ให้พิจารณาค่าฝุ่นละอองจากสถานีตรวจวัดที่ใกล้ที่สุด			
20	**พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 4 ราย** ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน (ตำบล/แขวง) เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (OPD/IPD) ที่มีประวัติการรับสัมผัสฝุ่น $PM_{2.5}$ และ/หรือมีการลงรหัสโรค (ICD-10) Z58.1 (การสัมผัสมลพิษทางอากาศ) **ร่วมกับ** มีอาการและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ด้วย**โรคใดโรคหนึ่ง** ดังต่อไปนี้ 1) **โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง** (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย J44 ทั้งหมด)	**พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 ราย** ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน (ตำบล/แขวง) เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (OPD/IPD) ที่มีประวัติการรับสัมผัสฝุ่น $PM_{2.5}$ และ/หรือมีการลงรหัสโรค (ICD-10) Z58.1 (การสัมผัสมลพิษทางอากาศ) **ร่วมกับ** มีอาการและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ด้วย**โรคใดโรคหนึ่ง** ดังต่อไปนี้ **1) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง** (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย J44 ทั้งหมด)	**พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 6 ราย** ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน (ตำบล/แขวง) เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (OPD/IPD) ที่มีประวัติการรับสัมผัสฝุ่น $PM_{2.5}$ และ/หรือมีการลงรหัสโรค (ICD-10) Z58.1 (การสัมผัสมลพิษทางอากาศ) **ร่วมกับ** มีอาการและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ด้วย**โรคใดโรคหนึ่ง** ดังต่อไปนี้ **1) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง** (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย J44 ทั้งหมด)

เกณฑ์สำหรับการออกดำเนินการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม			
ลำดับ	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สถานพยาบาล สำนักอนามัย กทม.**	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สปคม.**	**กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ / กรมควบคุมโรค**
	2) **โรคหืด** (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย J45 ทั้งหมด) 3) **กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน** (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย I21, I22, I24 ทั้งหมด) 4) **กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ** (L30.9 และรหัสที่ขึ้นต้นด้วย L50 ทั้งหมด) **5) โรคเยื่อตาอักเสบ** (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย H10 ทั้งหมด)	**2) โรคหืด** (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย J45 ทั้งหมด) **3) กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน** (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย I21, I22, I24 ทั้งหมด) **4) กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ** (L30.9 และรหัสที่ขึ้นต้นด้วย L50 ทั้งหมด) **5) โรคเยื่อตาอักเสบ** (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย H10 ทั้งหมด)	**2) โรคหืด** (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย J45 ทั้งหมด) **3) กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน** (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย I21, I22, I24 ทั้งหมด) **4) กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ** (L30.9 และรหัสที่ขึ้นต้นด้วย L50 ทั้งหมด) **5) โรคเยื่อตาอักเสบ** (รหัสที่ขึ้นต้นด้วย H10 ทั้งหมด)
21	**เหตุการณ์หรืออาการผิดปกติอื่นๆ** ที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่น $PM_{2.5}$ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือสาธารณชน (แล้วแต่กรณีหรือเหตุการณ์)	**เหตุการณ์หรืออาการผิดปกติอื่นๆ** ที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่น $PM_{2.5}$ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือสาธารณชน (แล้วแต่กรณีหรือเหตุการณ์)	**เหตุการณ์หรืออาการผิดปกติอื่นๆ** ที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่น $PM_{2.5}$ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือสาธารณชน (แล้วแต่กรณีหรือเหตุการณ์)
โรค/ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้ระบุใน พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562			
22	เหตุการณ์ที่เกิดจากการได้รับสัมผัสก๊าซพิษต่างๆ ในพื้นที่จำกัด คับแคบ อากาศถ่ายเทไม่สะดวกและไม่ได้เกิดจากการประกอบอาชีพ (ไม่สามารถเข้าได้กับนิยาม“ที่อับอากาศ” ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562) เช่น เหตุการณ์ที่เกิดจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซ เหตุการณ์ได้รับก๊าซในรถตู้โดยสาร เต้นท์หรือกระโจม เป็นต้น **เสียชีวิต ตั้งแต่ 1 ราย หรือได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 2 ราย ในเหตุการณ์เดียวกัน** โดยไม่ร่วมถึงกรณีที่เจตนาฆ่าตัวตายหรือถูกทำร้าย	เหตุการณ์ที่เกิดจากการได้รับสัมผัสก๊าซพิษต่างๆ ในพื้นที่จำกัด คับแคบ อากาศถ่ายเทไม่สะดวกและไม่ได้เกิดจากการประกอบอาชีพ (ไม่สามารถเข้าได้กับนิยาม“ที่อับอากาศ” ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562) เช่น เหตุการณ์ที่เกิดจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซ เหตุการณ์ได้รับก๊าซในรถตู้โดยสาร เต้นท์หรือกระโจม เป็นต้น **เสียชีวิต ตั้งแต่ 2 ราย หรือได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 3 ราย ในเหตุการณ์เดียวกัน** โดยไม่ร่วมถึงกรณีที่เจตนาฆ่าตัวตายหรือถูกทำร้าย	เหตุการณ์ที่เกิดจากการได้รับสัมผัสก๊าซพิษต่างๆ ในพื้นที่จำกัด คับแคบ อากาศถ่ายเทไม่สะดวกและไม่ได้เกิดจากการประกอบอาชีพ (ไม่สามารถเข้าได้กับนิยาม“ที่อับอากาศ” ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562) เช่น เหตุการณ์ที่เกิดจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซ เหตุการณ์ได้รับก๊าซในรถตู้โดยสาร เต้นท์หรือกระโจม เป็นต้น **เสียชีวิต ตั้งแต่ 3 ราย หรือได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 4 ราย ในเหตุการณ์เดียวกัน** โดยไม่ร่วมถึงกรณีที่เจตนาฆ่าตัวตายหรือถูกทำร้าย

เกณฑ์สำหรับการออกดำเนินการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม			
ลำดับ	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สถานพยาบาล สำนักอนามัย กทม.**	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สปคม.**	**กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ / กรมควบคุมโรค**
23	เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ ที่ไม่สามารถระงับเหตุการณ์ได้ภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ โดยอาจมีหรือไม่มีผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ หรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์	เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ ที่ไม่สามารถระงับเหตุการณ์ได้ภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ **ร่วมกับ**มีผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ ตั้งแต่ 10 ราย หรือเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล (OPD) ตั้งแต่ 5 ราย **หรือ**เป็นผู้ป่วยใน (IPD) ตั้งแต่ 3 ราย **หรือ**ต้องมีการอพยพประชาชนไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว	เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ ที่ไม่สามารถระงับเหตุการณ์ได้ภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ **ร่วมกับ**มีผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ ตั้งแต่ 10 ราย หรือเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล (OPD) ตั้งแต่ 5 ราย **หรือ**เป็นผู้ป่วยใน (IPD) ตั้งแต่ 3 ราย **หรือ**ต้องมีการอพยพประชาชนไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
24	ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษโลหะหนัก (ไม่รวมโรคพิษตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว) **หรือ** สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) **ตั้งแต่ 3 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน**	ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษโลหะหนัก (ไม่รวมโรคพิษตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว) **หรือ** สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) **ตั้งแต่ 5 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน**	ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษโลหะหนัก (ไม่รวมโรคพิษตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว) **หรือ** สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) **ตั้งแต่ 10 ราย ในเหตุการณ์หรือสถานที่ทำงานเดียวกัน**
25	ผู้เสียชีวิตที่ได้รับการ**วินิจฉัยยืนยันจากแพทย์ด้วยโรคลมร้อน (heat stroke) ตั้งแต่ 1 ราย**	ผู้เสียชีวิตที่ได้รับการ**วินิจฉัยยืนยันจากแพทย์ด้วยโรคลมร้อน (heat stroke) ตั้งแต่ 2 ราย ที่มีกิจกรรมร่วมกัน**	ผู้เสียชีวิต ที่ได้รับการ**วินิจฉัยยืนยันจากแพทย์ด้วยโรคลมร้อน (heat stroke) ตั้งแต่ 3 ราย ที่มีกิจกรรมร่วมกัน**
	อุบัติภัยสารเคมี		
26	เหตุการณ์สารเคมีระเบิด ไฟไหม้ รั่วไหล ในสถานประกอบกิจการ เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตราย โรงงานพลุ เป็นต้น **หมายเหตุ :** ลงสอบสวนโรค กรณีเข้าเกณฑ์เฉพาะเหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูง	เหตุการณ์สารเคมีระเบิด ไฟไหม้ รั่วไหล ในสถานประกอบกิจการ เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตราย โรงงานพลุ เป็นต้น **หมายเหตุ :** ลงสอบสวนโรค กรณีเข้าเกณฑ์เฉพาะ เหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูง	เหตุการณ์สารเคมีระเบิด ไฟไหม้ รั่วไหล ในสถานประกอบกิจการ เช่น นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตราย โรงงานพลุ เป็นต้น **หมายเหตุ :** ลงสอบสวนโรค กรณีเข้าเกณฑ์เฉพาะเหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูง

เกณฑ์สำหรับการออกดำเนินการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม			
ลำดับ	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สถานพยาบาล สำนักอนามัย กทม.**	**สำนักงานป้องกันควบคุมโรค/สปคม.**	**กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ / กรมควบคุมโรค**
27	อุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมี ทำให้เกิดสารเคมีรั่วไหล/ระเบิด/ไฟไหม้ **ร่วมกับ**มีผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมี/บาดเจ็บ **ตั้งแต่ 3 ราย**	อุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมี ทำให้เกิดสารเคมีรั่วไหล/ระเบิด/ไฟไหม้ **ร่วมกับ**มีผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมี/บาดเจ็บจากเหตุการณ์ **ตั้งแต่ 5 ราย**	อุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมี ทำให้เกิดสารเคมีรั่วไหล / ระเบิด/ไฟไหม้ **ร่วมกับ**มีผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมี/บาดเจ็บจากเหตุการณ์ **ตั้งแต่ 10 ราย**
28	เหตุการณ์ลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม **ร่วมกับ** มีผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ เช่น มีอาการเวียนศีรษะ มึนงง แสบจมูก หายใจลำบาก อ่อนเพลีย เป็นต้น **ตั้งแต่ 5 ราย ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/พื้นที่เดียวกัน**	เหตุการณ์ลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม **ร่วมกับ** มีผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ เช่น มีอาการเวียนศีรษะ มึนงง แสบจมูก หายใจลำบาก อ่อนเพลีย เป็นต้น **ตั้งแต่ 10 ราย ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/พื้นที่เดียวกัน**	เหตุการณ์ลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม **ร่วมกับ** มีผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพ เช่น มีอาการเวียนศีรษะ มึนงง แสบจมูก หายใจลำบาก อ่อนเพลีย เป็นต้น **ตั้งแต่ 15 ราย ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/พื้นที่เดียวกัน**
	เหตุการณ์อื่นๆ		
29	การเสียชีวิตที่สงสัยว่ามีสาเหตุเดียวกันในสถานประกอบกิจการเดียวกัน **ตั้งแต่ 2 ราย หรือ** การเกิดโรคหรืออาการที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเป็นโรคที่หายาก **ตั้งแต่ 1 ราย**	การเสียชีวิตที่สงสัยว่ามีสาเหตุเดียวกันในสถานประกอบกิจการเดียวกัน **ตั้งแต่ 2 ราย หรือ** การเกิดโรคหรืออาการที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเป็นโรคที่หายาก **ตั้งแต่ 1 ราย**	การเสียชีวิตที่สงสัยว่ามีสาเหตุเดียวกันในสถานประกอบกิจการเดียวกัน **ตั้งแต่ 2 ราย หรือ** การเกิดโรคหรืออาการที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเป็นโรคที่หายาก **ตั้งแต่ 1 ราย**